Cabinet de dermatologie Es-Senia

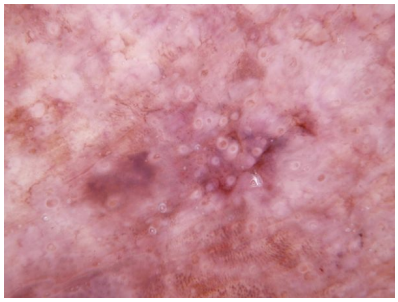
تقرير المساعدة على الفرز — آفة جلدية

dermIA الإصدار 2.0.0 · النموذج ham10000-m5-v2 الإصدار 2.0.0 (الملف: كامل)

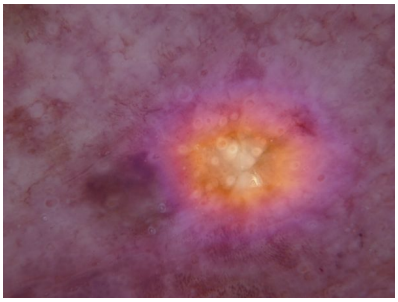
المريض	P-2026-0424	تاريخ التحليل	08:39 08/10/2026
العمر (بالسنوات)	70	طلب التحليل	Dr Karim Haddad
الجنس	أنثى	الموضع	الوجه
الآفة المتابعة	رقم 1	عتبات القرار	الأصلية

رأي مختص

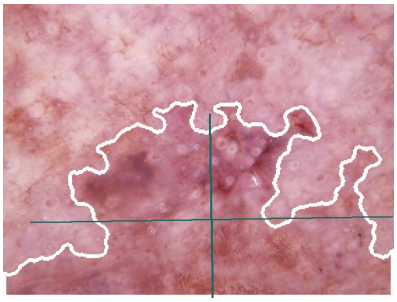
تقرن سفعي / داء بوين مرجح
آفة خبيثة أو سابقة للخباثة على الأرجح. يوصى باستشارة طبيب الأمراض الجلدية.



الصورة المحللة



المناطق الأكثر تأثيرا (Grad-CAM، «تقرن سفعي / داء بوين»)



الحدود والمحاور المستخدمة في معايير ABCD

الاحتمالات المقدرة

التشخيص	الاحتمال	ضمن المجموعة المضمونة*
تقرن سفعي / داء بوين	86,2%	نعم
تقرن حميد	13,5%	
ورم ميلانيني	0,1%	
سرطانة الخلايا القاعدية	0,1%	
ورم ليفي جلدي	0,0%	
وحمة ميلانينية	0,0%	
آفة وعائية	0,0%	

* المجموعة المطابقة (طريقة موندريان، ألفا = 0,10): تحتوي على التشخيص الصحيح باحتمال لا يقل عن 90% لكل فئة، بافتراض أن الحالات تشبه بيانات المعايرة. يتخذ قرار الورم الميلانيني إذا كان p(mel) ≥ 0,10 (نسبة التكلفة R = 10).
عتبات النموذج الأصلية، معايرة على مجموعة المعايرة من HAM10000.

معايير ABCD الآلية (استرشادية)

المعيار	القياس	التفاصيل
A — عدم التناظر	2/2	محاور رئيسية غير متناظرة (الشكل أو الألوان)
B — الحواف	3/8	قطاعات ذات حافة حادة
C — الألوان	3/6	أبيض، بني داكن، أزرق رمادي
D — القطر	15,5 مم	أكثر من 6 مم

تنبيه: تلامس الآفة حافة الصورة: المعايير A وB وD أقل موثوقية.
قياسات آلية استرشادية: على مجموعة الاختبار من HAM10000 لا يميز كل منها بين الورم الميلانيني والوحمة إلا بشكل محدود (AUC من 0,66 إلى 0,73). وهي لا تغني عن الفحص بالمنظار الجلدي.

المراجعة الطبية

لم يراجعها طبيب بعد.

توقيع الطبيب: _____

تنبيه. أعدت هذه الوثيقة بواسطة أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهي لا تعد تشخيصا ولا تغني عن الفحص السريري ولا عن الفحص النسيجي. حالة النموذج: عرض توضيحي — استخدام غير تجاري — ليس جهازا طبيا. بيانات التدريب: HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) — الترخيص CC BY-NC 4.0 (غير تجاري).